

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Choledochoduodenostomy / Enterostomy

معلومات الإقرار – نسخة المريض

توصيل القنوات المرارية بالاثني عشر أو
الأمعاء الدقيقة

1. What is a cholecystoduodenostomy / enterostomy?

This is a procedure where the hepatic or bile duct is connected to the duodenum (part of the stomach) or small bowel, to allow bile to drain.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.

1. ماهي المفاغرة المرارية الإثناعشرية؟

هو إجراء يتم فيه ربط القنوات المرارية الكبدية أو الصفراوية بالاثني عشر (جزء من المعدة) أو الأمعاء الدقيقة للسماح بتصريف المادة الصفراء.

2. التخدير الذي أتلناه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب إعادةك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث إنسداد للشعبات الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر بمضاعفات في القلب والرئة،

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery.
- Damage may occur to the bile ducts near the liver and gall bladder with long term problems with blockage
- Difficulty passing urine after the operation and may need a catheter passed into the bladder, until the bladder can empty normally.
- The join between the ducts/gall bladder and bowel may not heal properly and cause leakage of bowel fluid. This may need further surgery.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with bloating of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- The jaundice for which this operation is done may not clear up.
- In some people, healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red and the scar may be painful.
- A weakness can occur in the wound with the development of a hernia. This may need further surgery.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.

وجلطات الأوعية الدموية

- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة متعلقة بهذا الإجراء:

- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- حدوث ضرر للأنايب المرارية بالقرب من الكبد والحويلة المرارية مسبباً مشكلات قصيرة وطويلة الأمد من الانسداد.
- صعوبة في إدرار البول بعد الجراحة ، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة لإخراج البول حتى تتمكن المثانة من إخراج البول بشكل طبيعي.
- نقطة الاتصال بين القناة المرارة والأمعاء قد لا تلتئم بشكل صحيح وتسبب تسريب لسوائل الأمعاء . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- قد تصاب حركة الأمعاء بالانسداد ببطء الحركة بعد العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيد. قد يتطلب الأمر علاج آخر.
- الإصابة بالتهاب في سوائل البطن كتجمعات للصدى في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً .
- عدم الشفاء من اليرقان (الصفار) الذي أجريت الجراحة لعلاج .
- عند بعض المرضى ، يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الجرح ويصبح لونه أحمر وقد يكون الندب مؤلماً.
- قد تصبح منطقة الجرح ضعيفة وينشأ فيها فتق . قد يتطلب علاج ذلك جراحة أخرى.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Notes to talk to my doctor about:

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
